

Saúde na Última Semana — Revista Eletrônica VIA

Edição de 27 de setembro de 2026

Semana de 21 a 27 de setembro de 2026

Curadoria médico-científica · saúde pública, cuidado, ciência e tecnologia

Esta semana o Estado não lançou molécula — reordenou o circuito: o que pode circular, o que o plano é obrigado a cobrir e o que o SUS é chamado a reavaliar.

Em 90 segundos

- Nesta edição, um nome da casa: Prof. Dr. José Sebastião dos Santos — Titular de Cirurgia na FMRP-USP; diretor pro tempore da FMBRU-USP e dirigente do HRAC/Centrinho.
- O Ministério da Saúde protocolou à Conitec, em 24/09, pedido formal de análise para incorporar agonistas de GLP-1 ao SUS — pedido formal não é portaria de incorporação.
- A Anvisa apreendeu e proibiu dois lotes irregulares de Ocrevus (ocrelizumabe) pela Resolução-RE nº 3.751, publicada no DOU em 25/09.
- A ANS, pela Resolução Normativa nº 680 (DOU 22/09), inclui o DIU hormonal no rol para endometriose com contraindicação ou não adesão a contraceptivos orais combinados; vigência a partir de 01/10.
- A Anvisa alertou, em 23/09, contra manipulação caseira de tirzepatida em pó e contra o peptídeo experimental CBL-514 sem registro.
- Continuidade com a edição de 20/09: o piso mudou (há protocolo formal); o teto não (ainda não há incorporação nem protocolo nacional de oferta).

1. SUS — O pedido voltou à mesa

Na edição de 20 de setembro, o anúncio de medicamentos para obesidade no SUS chegou antes da incorporação. O fato desta semana muda o piso regulatório: em 24 de setembro de 2026, o Ministério da Saúde protocolou na Conitec pedido formal de análise para incorporação das chamadas “canetas emagrecedoras” — agonistas do receptor de GLP-1 — ao rol de medicamentos do SUS.

O comunicado oficial do MS fundamenta a reabertura com redução de preços (queda de até cerca de 70% em menos de um ano), ampliação da oferta nacional (25 canetas registradas no país, das quais 14 em 2026) e o agravamento epidemiológico da obesidade — prevalência de 11,8% em 2006 para 25,7% em 2024. Cita semaglutida e liraglutida no escopo em discussão.

Protocolo não incorpora. Prevalência descreve o problema; não decide a avaliação de tecnologia. Ainda não há portaria de incorporação nem protocolo nacional de oferta. A pergunta correta permanece a mesma da edição anterior: em quais pacientes o tratamento modifica doença, complicações e trajetória clínica — e a que custo, risco e necessidade de acompanhamento.

Fonte primária: [Ministério da Saúde — protocolo na Conitec, 24/09/2026](#).

2. Vigilância — Dois lotes fora do circuito

A Anvisa determinou a apreensão de dois lotes de Ocrevus (ocrelizumabe) 300 mg/10 ml — lotes H7953B14 e H7953B06 — indicados para esclerose múltipla, por importação e distribuição irregulares. A medida consta da Resolução-RE nº 3.751, de 24 de setembro de 2026, publicada no Diário Oficial da União em 25/09/2026.

A resolução proíbe armazenamento, venda, distribuição, importação, propaganda e transporte desses lotes. A distribuição irregular apontada remonta a julho/2026, via distribuidora com Autorização de Funcionamento (AFE) inativa. Não é juízo sobre o fármaco na indicação aprovada de esclerose múltipla: é juízo sobre o lote e sobre quem o pôs a circular.

Fonte primária: [Resolução-RE nº 3.751/2026 — DOU 25/09/2026](#).

3. Suplementar — O rol chegou na endometriose

A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu o DIU hormonal na cobertura obrigatória dos planos de saúde para pacientes com endometriose que apresentam contraindicação ou não adesão a contraceptivos orais combinados. A norma é a Resolução Normativa ANS nº 680, de 18 de setembro de 2026, publicada no DOU em 22/09/2026. A vigência da cobertura obrigatória — dispositivo e procedimento de inserção — começa em 1º de outubro de 2026.

Não é DIU obrigatório para qualquer contracepção. O rol descreve cobertura numa indicação delimitada: endometriose com contraindicação ou não adesão a COC. Carimbo normativo (DOU 22/09) não se confunde com carimbo de vigência (01/10).

Fonte primária: [Resolução Normativa ANS nº 680/2026 — DOU 22/09/2026](#).

4. Mercado — Pó não é prescrição

Em 23 de setembro de 2026, a Anvisa alertou para a venda irregular de tirzepatida em pó em redes sociais, acompanhada de tutoriais de autoaplicação sem controle sanitário. O mesmo aviso reforça a fiscalização sobre o peptídeo experimental CBL-514, ainda sem registro no Brasil.

Não há métrica quantitativa na fonte primária — sem inventar escala, perfil, apreensão nem volume de venda. O contraste com o fio da edição é direto: registro, incorporação ao SUS e prescrição clínica respondem a perguntas diferentes; pó manipulado fora do circuito sanitário não é atalho para nenhuma delas.

Fonte primária: [Anvisa — manipulação caseira de tirzepatida não é segura](#).

Aos que ensinam



Prof. Dr. José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP)

Prof. Dr. José Sebastião dos Santos, diretor da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP). Foto: STE/FOB-USP — [USP Campus Bauru](#).

Prof. Dr. José Sebastião dos Santos, professor titular de Cirurgia na FMRP-USP e diretor (pro tempore) da Faculdade de Medicina de Bauru (FMBRU-USP), também figura como dirigente do HRAC/Centrinho. Formou-se em Medicina em São José do Rio Preto (1984) e fez residência, mestrado, doutorado e livre-docência em Cirurgia na FMRP/HC-FMRP-USP. Na carreira acadêmico-gestora, passou pela direção da Unidade de Emergência do HC-FMRP, pela Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto, pela chefia do DCA da FMRP (2017–2019) e pela coordenação do curso de Medicina da USP em Bauru. Em março de 2026, na celebração dos dois anos da FMBRU, destacou a consolidação da graduação, da especialização e da pós-graduação na unidade mais nova da USP.

Fonte: [Diretoria — Faculdade de Medicina de Bauru / USP](#).

O que a VIA leva desta semana

- Pedido formal à Conitec não é incorporação ao SUS.
- Interditar lotes irregulares não é juízo sobre o fármaco na indicação aprovada.
- Incluir tecnologia no rol da ANS é cobertura numa indicação — não direito irrestrito ao dispositivo.
- Alerta sanitário contra pó e peptídeo sem registro não inventa métrica onde a fonte não a dá.
- O fio não é a molécula: é o circuito — o que pode circular, o que o plano cobre e o que o SUS reavalia.

Na folha de 20/09 o anúncio chegou antes da incorporação. Nesta, o piso mudou; o teto não. Ciência e tecnologia entram no cuidado por uma cadeia de decisões. A qualidade dessa cadeia importa tanto quanto a novidade que circula por ela.

Método editorial

Fatos regulatórios e institucionais foram conferidos em fontes primárias (.gov.br / in.gov.br). Declaração ministerial, protocolo de solicitação, resolução sanitária, resolução normativa de cobertura e alerta de vigilância são categorias distintas. A edição preserva essa separação. Âncoras sem primária oficial homologada não entram.

Material educativo. Não substitui avaliação clínica individual, protocolo assistencial, norma sanitária nem fonte epidemiológica em tempo real. Não é bula, não é laudo, não é autorização de uso. Conduta parte de prescrição e de vínculo clínico.

Dr Lucas HR Almeida Editorial · Médico generalista (FMRP-USP) CRM-SP 226836 · CRM-MG 109752